



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : عيبر فوزي توفيق محمد
المحافظة : المنيا
الحى / المدينة : ابوقرقاص
رقم البطاقة : 27608072400569 رقم التليفون : 01148846247
العنوان : الزهير
العمر (تاريخ الميلاد) : 07-08-1976 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عيبر فوزي توفيق محمد National ID: 27608072400569	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Name: عبير فوزي توفيق		
MR. : 4247		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه Imaging performed on 6/3/2026, including transvaginal ultrasound, was reported as entirely normal. Endometrial thickness measured 9 mm, and the bilateral salpingo-ovarian masses were absent. The plan is to continue tamoxifen to complete a total of five years of therapy and to repeat estradiol (E2) testing in six months; the most recent laboratory values showed follicle-stimulating hormone (FSH) 30 IU/L and estradiol 203 pg/mL, consistent with premenopausal hormone levels despite amenorrhea since chemotherapy. The patient was seen on 21/5/2026 for continuation of tamoxifen 20 mg daily as supportive treatment. The current plan is to maintain tamoxifen therapy and continue routine follow-up.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	ندى حسن صلاح كامل	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name : الأستاذ / صبير فوزي توفيق	Request No. : 13005715
Patient No. : 27608072400569	Request Date : 24/06/2023
Path No. : 2048/23	Verification Date : 26/06/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 46 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast mass lesion

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 22-6-2023 (4:20PM)

Gross Examination:

Four greyish white tissue cores up to 1.5 cm . Totally submitted .

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive lobular carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Focal lobular component

Diagnosis:

Left breast mass lesion , Tru cut biopsy:

- Invasive lobular carcinoma grade II with focal lobular component .
- For IPT (ER-PR-HER2-KI67)

Prof.Dr.Manal Elmahdy
Dr.Israa Elgendy

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 09/07/2023 09:42:13

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name: Abeer Fawzy Tawfik Mohamed	Date : 09/07/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2506/2023	Pat. ID: 39200

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Left breast UIQ few soft tissue density lesions, the largest measuring about 1 x 1.5 cm.
- Prominent left axillary level I measuring about 1.6 x 0.9 cm.
- No sizable pulmonary nodules, no masses or consolidation.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renals.
- Bulky uterus is seen.



Patient Name: Abeer Fawzy Tawfik Mohamed	Date : 20/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2506/2023	Pat. ID: 39200

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM in

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C),
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

20/03/2025 2:10 PM

Patient Name: Abeer Fawzy Tawfik Mohamed	Date : 09/07/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2506/2023	Pat. ID: 39200

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Left breast UIQ few soft tissue density lesions, the largest measuring about 1 x 1.5 cm.
- Prominent left axillary level I measuring about 1.6 x 0.9 cm.
- No sizable pulmonary nodules, no masses or consolidation.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renals.
- Bulky uterus is seen.

Patient Name : الأستاذة / عبير فوزي توفيق
Patient No. : 27608072400569
Path No. : 2048/23
Sex : Female
Age : 46 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13005715
Request Date : 24/06/2023
Verification Date : 17/07/2023
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Left breast mass lesion

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 22-6-2023 (4:20PM)

Gross Examination:

Four greyish white tissue cores up to 1.5 cm . Totally submitted .

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma

Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G li(3+2+1)

Focal lobular component

IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :

ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Strong nuclear reaction in 80 of tumor cells (Allred score 8/8)

HER2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)

Ki 67: 15 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis:

Left breast mass lesion , Tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma grade II with focal lobular cancerization.

IPT:

E-cadhrein:Positive

ER: Positive (score 8/8).

PR: Positive (score 8/8).

HER2: Negative (score 0).

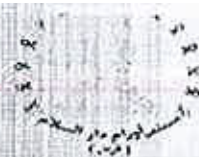
Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 18/07/2023 11:22:05

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youss



Patient Name: Abeer Fawzy Tawfik Mohamed	Date : 09/07/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 2506/2023	Pat. ID: 39200

**NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Left breast UIQ few soft tissue density lesions, the largest measuring about 1 x 1.5 cm.
- Prominent left axillary level I measuring about 1.6 x 0.9 cm.
- No sizable pulmonary nodules, no masses or consolidation.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renals.
- Bulky uterus is seen.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- IUD is noted.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.
- L4 limbus vertebra.



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



لجنة MDT

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : عبيد فوزي توفيق محمد

Sex:

3- Medical number:

Female

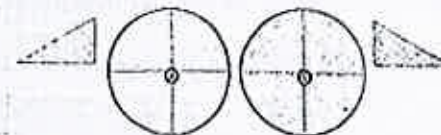
83150869

Old Med :

2506-2023

2-ID number: 27608072400569

Patient Age: 47 Y



Family history

Phone

01158685863

BMI

REASON OF MDT

POST OPERATIVE

marital status

NRS Score

01158685863

GROUP

3

Date of MDT

2023-09-26

☐

Co morbidity

Menopausal status

PREMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

no mets

BX:

IDC

ER:

8/8

PR:

8/8

Her 2 Neu :

0

SISH :

Ki67 :

15

g2

T

ct2 multifocal

N

0

M

0

Sonomammography

LT UIQ FOCAL a symmetry 7*9cm+ non specific axillary LN

PATIENT HISTORY

bil.sm: lt UIQ FOCAL ASYMMETRY WITH RELATED AMORPHOUS CALCIFICATION 7X9CM , LT UIQ EXTEN MULTIPLE SUSPICIOUS MASSES

MRI BREAST:

ABNORMAL SIGNAL AT UPPER AND LOWER INNER QUADRANTS WITH EXTENSION TO

MDT OUTCOME & PLAN

FOR TC 4CYCLES

TAMOFEN , 20mg

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

د. شريف مكي

RADIOLOGY

د. محمد

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition